

Urgenze Pediatriche: Il Ruolo del Volontario S.S.E.

Modulo S.S.E. - Capitolo 2



Benvenuti!

- Siamo Nicolò e Alessandra, istruttori certificati AREU e volontari soccorritori-esecutori in Croce Verde Baggio.
- Oggi affronteremo insieme uno degli argomenti che più spaventa un soccorritore: **l'emergenza medica nel bambino e nell'adolescente**.
- Vi daremo strumenti pratici per gestire la scena, i parametri e lo stress—vostro e del paziente.



Nota: Ricordate sempre la corretta pronuncia. Si dice "aréu" (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), non "àreu".

Non è un “Piccolo Adulto”

La comunicazione è la chiave per fornire la migliore assistenza

- Il bambino ha modi radicalmente diversi di farsi capire rispetto al mondo degli adulti.
- Vive paure e stress differenti, spesso incomprensibili per noi.



Dobbiamo sempre **trattare il bambino** coinvolgendo **attivamente la famiglia** e/o i **tutori**.
Il soccorso pediatrico è prima di tutto un **soccorso relazionale**.

Classificazione per Età Cognitiva e Relazionale



L'approccio pratico (es. dove rilevare un polso) cambia drasticamente muovendosi lungo questa linea.

Il Ruolo Fondamentale dei Genitori

Il bambino in età pediatrica dipende completamente dai genitori.
Loro sono i veri esperti del loro bambino.



Appena arrivate sul target,
la prima domanda chiave
porre a chi ha in carico il
il bimbo è:

**"Il bambino si
comporta in modo
diverso dal solito?"**

L'anamnesi inizia dall'osservazione dell'interazione genitore-figlio.

I Segni di Allarme Comportamentale

Prima ancora di misurare i parametri, osservate attentamente l'atteggiamento. Un bambino critico si presenta spesso:



Non distraibile

Non reagisce agli stimoli visivi o sonori esterni.



Meno attento/interattivo

Lo sguardo è perso, non cerca il contatto visivo.



Inconsolabile

Il pianto non cessa nemmeno tra le braccia della madre.

L'Approccio ABCDE in Età Pediatrica

La valutazione segue sempre la sequenza ABCDE, prestando estrema attenzione ad agitazione e sudorazione.



Focus Neurologico (AVPU)

Per una corretta valutazione, tenete conto delle capacità di interazione:

A (ALERT) nel bambino significa: segue con lo sguardo, riconosce i genitori e interagisce con essi.



Focus "B/C": Attenzione! La desaturazione nel bambino causa l'alterazione di tutti gli altri parametri vitali.

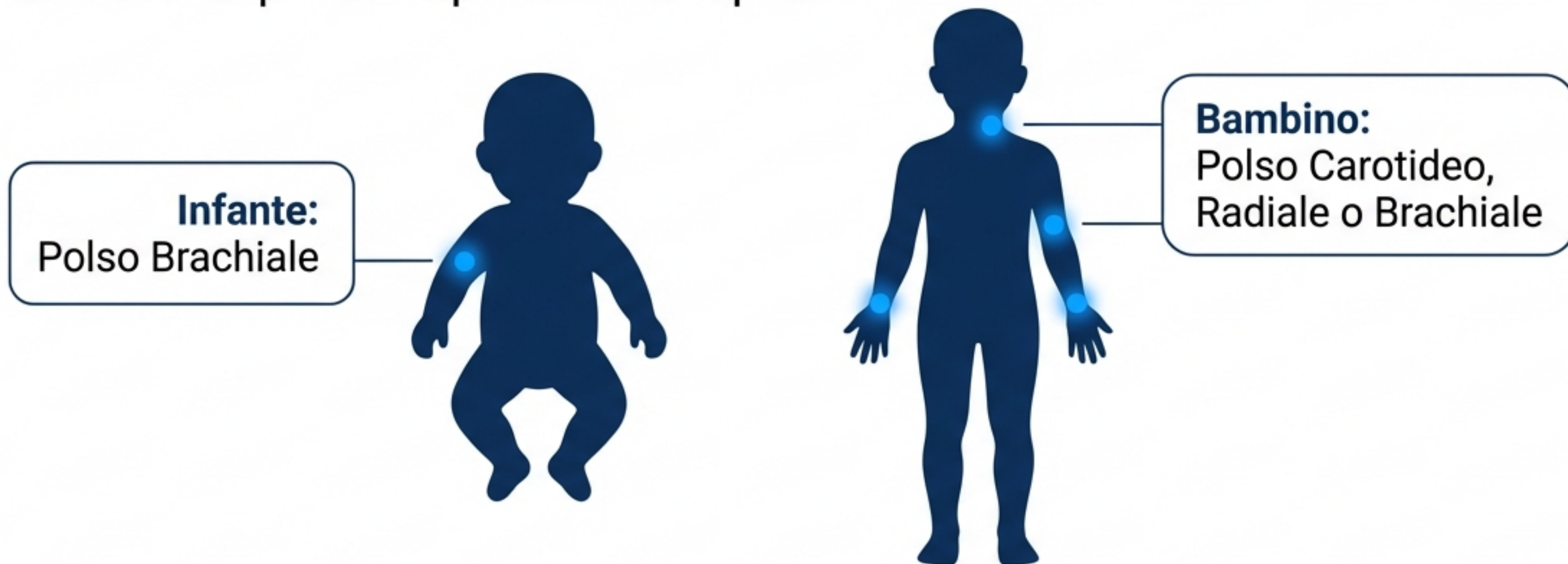
I Numeri del Soccorso: Parametri Vitali

Età	Peso	PAS	FC	FR
Infante	3-10 Kg	70-80 mmHg	120-150 b/min	30-40 a/min
2-4 anni	12-16 Kg	80-95 mmHg	100-110 b/min	20-30 a/min
5-8 anni	18-26 Kg	90-100 mmHg	90-100 b/min	14-20 a/min
8-12 anni	26-50 Kg	100-110 mmHg	80-100 b/min	12-20 a/min
> 12 anni	> 50 Kg	100-120 mmHg	60-90 b/min	12-16 a/min

PAS = Pressione Arteriosa Sistolica | FC = Frequenza Cardiaca | FR = Frequenza Respiratoria

Rilevazione Pratica S.S.E.

Saper dove cercare è fondamentale quanto sapere cosa cercare.
Assicuratevi sempre della presenza del polso.



Nota Istruttore: Ricordate l'uso corretto dell'italiano tecnico; parliamo di “presìdi” medici, con l'accento sulla ‘i’, non “présidi”. La professionalità si nota anche dal linguaggio.

Riconoscere il Distress Respiratorio

Segni chiave di un'alterata meccanica respiratoria da valutare immediatamente:



Visivi:

- Uso della **muscolatura accessoria**, alitamento delle pinne nasali.
- **Rientramento** del **giugolo**, rientramenti costali e sottocostali.
- **Postura iperestesa** (testa tirata indietro).
- Cambiamenti di **colore** (cianosi, pallore, arrossamento).



Uditivi:

- **Rumori respiratori** anomali (fischi, gemiti, stridor).



Il Bivio Clinico: Compenso vs. Scompenso

Fase di Compenso



- Mantiene meccanismi di compenso.
- Coscienza adeguata.
- Aumento contenuto della frequenza respiratoria.
- Buon tono muscolare.



Fase di Esaurimento



- Deterioramento della coscienza fino al coma.
- Aggravamento della cianosi.
- Nelle fasi terminali:
Bradicardia (FC < 80/min) e
Bradipnea.

La Regola d'Oro: Ridurre lo Stress



Di fronte a un bambino in fase di compenso respiratorio, l'obiettivo primario è non aggravare la condizione clinica aumentando le richieste ed il consumo di ossigeno.

Azione Pratica S.S.E.: Tutte le azioni del soccorritore devono seguire questo principio. Lasciate il bambino nella posizione più naturale e tranquillizzante, ovvero in braccio al genitore.

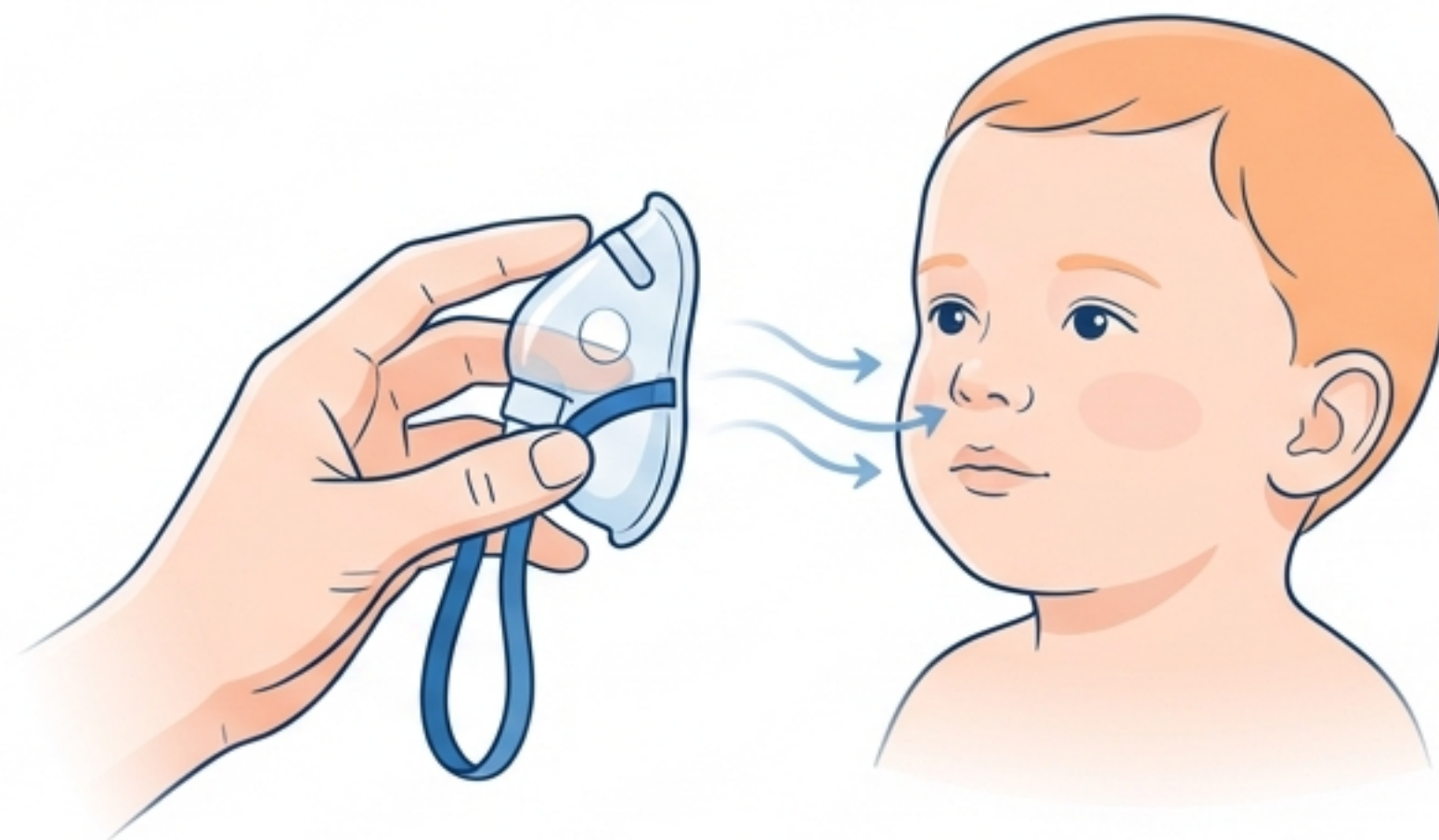
Gestione S.S.E: L'Ossigenoterapia

L'ossigenoterapia va somministrata quando possibile, ma ricordate: è utile, ma non indispensabile se diventa fonte di panico.

La Tecnica "Blow-By"

Va attuata solo se accettata senza problemi dal paziente.

Se il bambino non tollera il presidio sul volto, tenete la mascherina vicino al viso senza forzarlo. Non trasformate l'ossigeno in una tortura.



Il Decalogo del Volontario in Pediatria

- 1 Chiedi ai genitori:** Loro conoscono la normalità del bimbo.
- 2 Valuta a distanza:** Osserva distrazione, interazione e meccanica respiratoria prima di toccare.
- 3 Adatta l'AVPU:** 'Alert' significa che riconosce mamma e papà.
- 4 Non stressare:** Se compensato, lascialo in braccio ai genitori e adatta l'ossigenoterapia.



*La lucidità del soccorritore è la prima cura per il paziente. Grazie per l'impegno che mettete ogni giorno in Croce Verde Baggio. - **Nicolò e Alessandra***